

Asfixia, intoxicaciones y fiebre sin foco

1. Introducción y relevancia clínica

Las **urgencias pediátricas no traumáticas** incluyen un conjunto de cuadros que amenazan la vida y exigen una respuesta rápida, organizada y basada en protocolos.

Entre las más relevantes para el examen EUNACOM y la práctica clínica están:

1. **Asfixia o insuficiencia respiratoria aguda.**
2. **Intoxicaciones accidentales.**
3. **Fiebre sin foco en lactantes menores.**

Estos cuadros pueden presentarse en cualquier nivel de atención, y su **manejo inicial oportuno determina el pronóstico.**

2. Asfixia e insuficiencia respiratoria aguda

a.

Concepto

La **asfixia** corresponde a la **falla en el intercambio gaseoso**, con hipoxemia y/o hipercapnia, que sin intervención rápida puede causar **paro cardiorrespiratorio.**

b.

Causas más frecuentes por grupo etario

Edad	Causas más comunes
Recién nacido	Aspiración meconial, síndrome de dificultad respiratoria, apnea

Lactante Bronquiolitis, aspiración de cuerpo extraño, laringitis

Niño mayor Asma aguda grave, neumonía, anafilaxia, trauma torácico

c.

Fisiopatología

- Hipoxemia → hipoxia tisular → acidosis metabólica.
 - Aumento del trabajo respiratorio → fatiga → paro respiratorio.
-

d.

Clínica

- Taquipnea, uso de musculatura accesorio, retracciones intercostales.
 - Cianosis, quejido, aleteo nasal.
 - Saturación de O₂ < 90 %.
 - En casos graves: bradipnea, hipotonía, compromiso de conciencia.
-

e.

Manejo inicial (ABC del paciente pediátrico)

1 ☐ A: vía aérea

- Alinear cabeza-cuello (“olfateando”).
- Aspirar secreciones si necesario.
- Retirar cuerpos extraños visibles.

2 ☐ B: respiración

- Administrar **O₂ alto flujo (FiO₂ 100%)**.
- Monitorear SatO₂ .
- Si apnea o esfuerzo ineficaz → ventilación con bolsa-mascarilla.

3 ☐ C: circulación

- Monitoreo cardiaco y signos vitales.
- Canalizar vía venosa y tomar gases arteriales.

4 ☐ D: drogas / diagnóstico

- Identificar causa: asma, anafilaxia, cuerpo extraño.
- Tratar causa específica:
 - **Broncoespasmo:** salbutamol nebulizado.
 - **Anafilaxia:** adrenalina IM (0,01 mg/kg, máx. 0,3 mg).
 - **Cuerpo extraño:** maniobra de Heimlich o compresiones torácicas según edad.

☐ En EUNACOM: “Lactante con tos súbita, cianosis y silencio auscultatorio unilateral → sospechar aspiración de cuerpo extraño.”

f.

Prevención

- Supervisar alimentación y juegos en menores de 3 años.
 - No dar alimentos duros (maní, uvas enteras).
 - Educación en maniobras de desobstrucción a padres.
-

3. Intoxicaciones pediátricas

a.

Introducción

Las intoxicaciones son frecuentes en **niños entre 1 y 5 años**, por **ingesta accidental de medicamentos o productos domésticos**.

El pronóstico suele ser bueno si el manejo es precoz y adecuado.

b.

Principales agentes tóxicos en Chile

Grupo	Ejemplos	Efectos principales
Fármacos	Paracetamol, benzodiacepinas, hierro, antidepresivos tricíclicos	Hepatotoxicidad, depresión SNC, arritmias
Domésticos	Detergentes, hidrocarburos, cloro, pesticidas	Corrosión, neumonitis aspirativa
Plantas / alimentos	Hongos, belladona, marihuana	Efectos neurológicos o gastrointestinales

c.

Evaluación inicial

ABC y anamnesis dirigida:

- Producto, cantidad, hora de ingesta, síntomas, tratamientos previos.
- Peso del niño (para calcular dosis tóxica).

Signos de gravedad:

- Compromiso de conciencia, convulsiones.
 - Vómitos persistentes.
 - Inestabilidad hemodinámica o respiratoria.
-

d.

Manejo general (MINSAL / CIAT Chile)

1 ☐ **Soporte vital básico:** ABC + oxígeno + monitoreo.

2 ☐ **Evacuación del tóxico:**

- **Carbón activado 1 g/kg VO** (máx. 50 g) dentro de la primera hora si ingesta significativa.
- **NO inducir el vómito** ni usar jarabe de ipecacuana.
- **Lavado gástrico** solo si tóxico grave <1 h y paciente consciente/intubado.

3 ☐ **Antídotos específicos** (si aplica):

- Paracetamol → **N-acetilcisteína**.
- Benzodiacepinas → **Flumazenil**.
- Opiáceos → **Naloxona**.
- Organofosforados → **Atropina + pralidoxima**.

4 ☐ **Observación hospitalaria:** mínimo 6–12 h en ingestas potencialmente tóxicas.

e.

Criterios de derivación

- Ingesta de fármacos cardiovasculares o psicotrópicos.

- Intento suicida.
- Niños <6 meses.
- Síntomas neurológicos o respiratorios.

☐ **Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico (CIAT):** 800 371 800 – disponible 24 h.

4. Fiebre sin foco

a.

Definición

Fiebre >38 °C sin hallazgo clínico evidente tras una evaluación inicial adecuada.

b.

Importancia

En lactantes pequeños (especialmente <3 meses) puede ser **la única manifestación de infección bacteriana grave (IBG)**, como:

- Infección urinaria (ITU).
- Meningitis.
- Bacteriemia oculta.

c.

Abordaje según edad (Guía MINSAL 2023)

Edad	Evaluación y conducta
<28 días	Alta probabilidad de IBG → hospitalizar, exámenes completos y antibióticos empíricos.

1–3 meses Evaluar apariencia, leucocitos, PCR y EAS. Si aspecto tóxico → hospitalizar.

>3 meses Evaluación clínica y EAS; observar 24–48 h si sin foco ni signos de gravedad.

d.

Exámenes básicos

- Hemograma, PCR, hemocultivo.
 - EAS y urocultivo (descartar ITU).
 - Punción lumbar en lactantes febriles <3 meses.
 - Radiografía de tórax si síntomas respiratorios.
-

e.

Manejo

- **Niños <28 días:** hospitalización + **ampicilina + cefotaxima IV.**
 - **1–3 meses:** observar o hospitalizar según apariencia clínica.
 - **>3 meses:** antipiréticos y observación domiciliaria si buen estado general.
-

f.

Criterios de hospitalización

- Apariencia tóxica (letargo, hipotonía, mala perfusión).
- Fiebre persistente >39 °C sin foco >48 h.

- Lactante <1 mes.
- Laboratorio compatible con IBG.

□ En EUNACOM: “Lactante de 2 meses con fiebre sin foco → hospitalizar y tratar empíricamente con antibióticos IV.”

5. Complicaciones y pronóstico

Cuadro	Complicaciones posibles	Pronóstico
Asfixia	Paro cardiorrespiratorio, daño neurológico	Variable, depende del tiempo de hipoxia
Intoxicación	Falla multiorgánica, arritmias	Buena si manejo precoz
Fiebre sin foco	Sepsis, meningitis, shock séptico	Excelente si diagnóstico temprano

6. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

□ Perlas:

1. En **asfixia**, priorizar ABC y oxígeno al 100 %.
2. En **intoxicaciones**, carbón activado 1 g/kg dentro de la primera hora.
3. **Nunca inducir vómito.**
4. **CIAT (800 371 800):** asesoría toxicológica en Chile.
5. En **fiebre sin foco <28 días** → **hospitalización obligatoria.**
6. En lactante febril con buen aspecto >3 meses, observar 48 h.

7. **Desobstrucción de vía aérea** varía según edad (compresiones torácicas <1 año, Heimlich >1 año).

□ **Errores frecuentes:**

- Retrasar ventilación en asfixia por intentar canalizar vía venosa.
 - Administrar líquidos o jarabes en intoxicados sin vía aérea asegurada.
 - No contactar CIAT o no identificar tóxico exacto.
 - En fiebre sin foco, no obtener EAS/urocultivo.
 - Dar alta precoz a lactante febril menor de 3 meses.
-

7. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Asfixia:** urgencia vital; manejo inicial ABC + O₂ 100 %.
2. **Intoxicación:** carbón activado 1 g/kg si <1 h; nunca inducir vómito.
3. **CIAT Chile:** 800 371 800.
4. **Fiebre sin foco <28 días:** hospitalizar + antibióticos empíricos IV.
5. **Evaluación sistemática según edad y apariencia.**
6. **La mayoría de las intoxicaciones pediátricas son accidentales.**
7. Educación y prevención en el hogar son esenciales.